



PUC Minas

AULA · URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Sistematizacao do Atendimento

De triagem de enfermagem ao ABCDE: uma linguagem unica
para o paciente grave

Dr. Igor Cruz Morais

Clínica Médica · Cardiologia · Geriatria — CRM-MG 76695

Docente de Urgência e Emergência · Internato

INTERNATO · 9º PERÍODO
PUC MINAS — CONTAGEM

Ao final, voce sera capaz de...

- 01** Classificar o risco na chegada (Manchester) e diferenciar urgencia de emergencia.
- 02** Montar a sala com o MOVE: monitorizacao, oxigenio, acesso venoso e exames.
- 03** Conduzir a avaliacao primaria ABCDE, tratando primeiro o que mata primeiro.

Por onde vamos passar

01 Por que sistematizar o atendimento

02 Triagem de enfermagem - Manchester

03 MOVE - montagem da sala

04 Intervenções que salvam

05 Conceitos: urgência x emergência

06 Manchester x ESI e outros sistemas

07 ABCDE - avaliação primária

08 Armadilhas, quiz e mensagens finais



01

A porta de entrada

Por que padronizar a prioridade e a abordagem inicial do paciente grave.



POR QUE SISTEMATIZAR

O custo de nao ter um metodo

33%

apenas - adesao ao ABCDE em
pacientes instaveis na emergencia
(revisao 2024).

86%

sensibilidade do NEWS2 (≥ 5) para sepse,
contra 34% do qSOFA.

5 niveis

e o padrao validado de classificacao de
risco (Manchester e ESI).

Fontes: Olgers TJ et al. 2024 (ABCDE); NEWS2 vs qSOFA; AHRQ/ENA; GBCR.



CONCEITOS-CHAVE

Classificar não e diagnosticar

CLASSIFICACAO DE RISCO

Ordenar o atendimento pela GRAVIDADE, não pela ordem de chegada - feito pela enfermagem na

Manchester

Urgencia

Agravo sem risco imediato de morte, mas que exige cuidado em curto prazo.

Emergência

Risco iminente de morte ou de lesão grave - atendimento imediato.

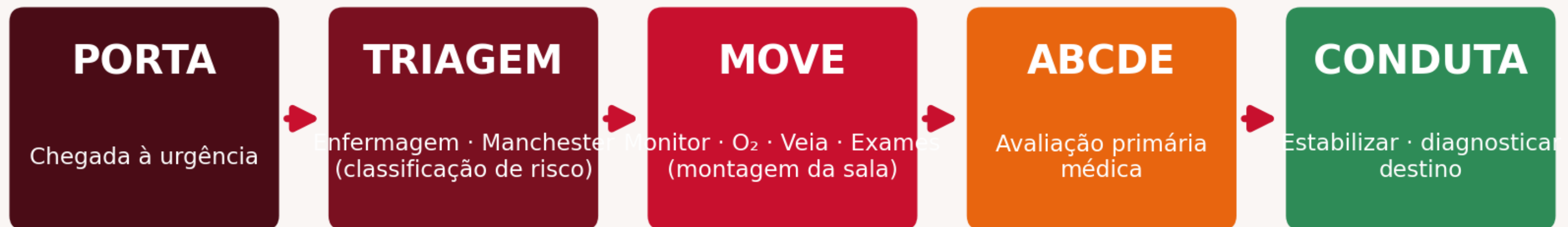
Acolhimento (ACCR)

PNH/Ministerio da Saude: acolher + classificar risco, obrigatório no SUS.



O caminho do paciente grave

O caminho do paciente grave — uma linguagem única



Reavaliar após CADA intervenção — 'trate primeiro o que mata primeiro'.

Enfermagem e equipe médica falando a mesma língua: prioridade por gravidade, não por ordem de chegada.

02

Triagem de enfermagem

A enfermagem classifica o risco e define o tempo-alvo de atendimento.



Protocolo de Manchester - 5 níveis

	Vermelho · Emergência	Atendimento imediato — risco de vida.	0 min
	Laranja · Muito urgente	Avaliação rápida e monitorização.	10 min
	Amarelo · Urgente	Atendimento prioritário, sem risco imediato.	60 min
	Verde · Pouco urgente	Pode aguardar atendimento eletivo.	120 min
	Azul · Não urgente	Condição não aguda — encaminhamento.	240 min

Manchester: cor e tempo-alvo

Protocolo de Manchester — prioridade por cor e tempo-alvo

VERMELHO	Emergência — risco de vida	Imediato (0 min)
LARANJA	Muito urgente	10 min
AMARELO	Urgente	60 min
VERDE	Pouco urgente	120 min
AZUL	Não urgente	240 min

5 níveis a partir da queixa de apresentação + discriminadores. No Brasil (GBCR), laranja muitas vezes é absorvido pelo vermelho.

TRIAGEM - COMO CLASSIFICAR

Da queixa ao nível de risco

- 1 Identifique a queixa de apresentação (dor torácica, dispneia, trauma...).
- 2 Aplique os discriminadores: risco de vida, dor, hemorragia, consciencia, temperatura.
- 3 O discriminador mais grave define a cor - e o tempo-alvo de atendimento.

Imagem real: sala de emergencia (Wikimedia Commons - CC BY-SA 2.0).



Sistemas validados de 5 niveis

Manchester

5 cores; tempo-alvo por discriminador.
Padrao no Brasil e na Europa.

ESI

5 niveis por gravidade + numero de
recursos. Padrao nos EUA (AHRQ/ENA).

CTAS / ATS

Canada e Australia - tambem de 5
niveis. Todos validados.

Manchester x ESI

Dois sistemas de 5 níveis — Manchester × ESI		
Aspecto	Manchester (MTS)	ESI
Origem	Reino Unido (1996)	EUA / AHRQ-ENA
Base da decisão	Queixa + discriminadores	Gravidade + nº de recursos
Níveis	5 cores (verm.→azul)	1 a 5 (1 = mais grave)
Define	Tempo-alvo de espera	Quem vê primeiro + recursos
Mais usado em	Brasil, Europa	EUA

Ambos validados e de 5 níveis. Outros: CTAS (Canadá) e ATS (Austrália). O essencial: padronizar a prioridade.

03

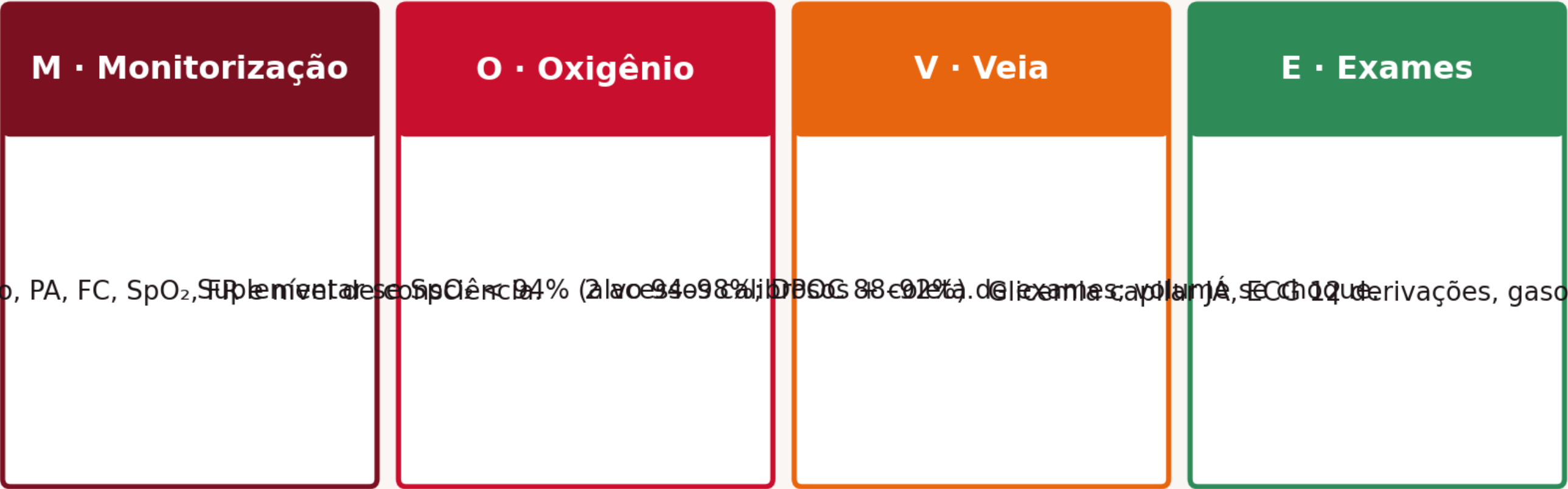
MOVE - montar a sala

Monitorizacao, oxigenio, acesso venoso e exames - em paralelo, em segundos.



MOVE - os primeiros segundos

MOVE — montar a sala em segundos



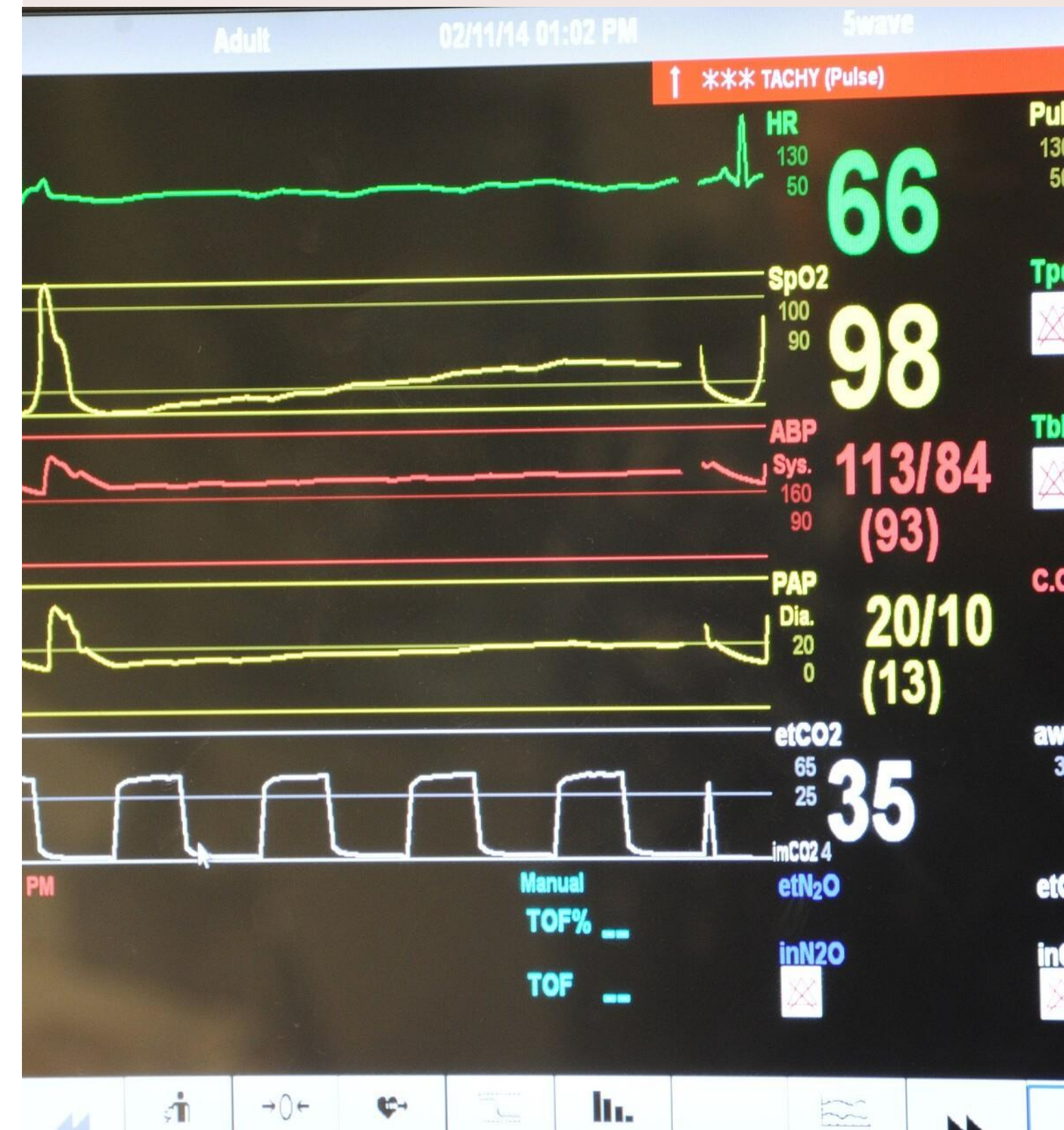
Feito em paralelo pela equipe, enquanto se inicia o ABCDE. 'E' = Exames e Examinar.

MOVE NA PRÁTICA

O que fazer nos primeiros minutos

- 1 Monitor multiparamétrico ligado: ECG contínuo, PA, FC, SpO2 e FR.
- 2 Oxigenio se SpO2 < 94%; dois acessos venosos calibrosos + coleta de exames.
- 3 Glicemia capilar imediata e ECG de 12 derivacoes.

Imagem real: monitor multiparamétrico (Wikimedia Commons - dominio publico).



04

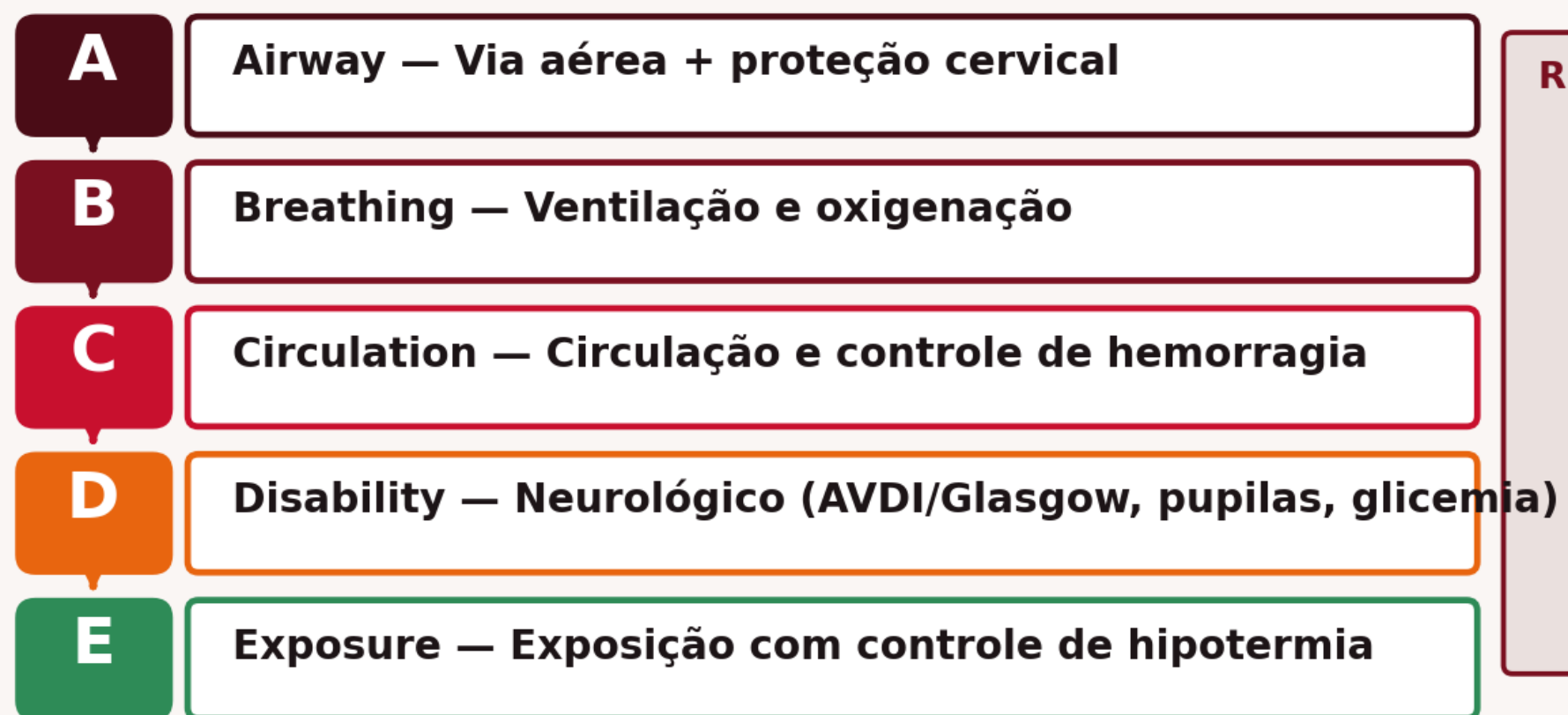
ABCDE - avaliacao primaria

Trate primeiro o que mata primeiro; reavalie a cada passo.



ABCDE - a ordem que salva

ABCDE — trate primeiro o que mata primeiro



REGRA DE OURO

Resolva cada letra antes de seguir.

Reavalie A→E após qualquer piora ou intervenção.

ABCDE na pratica - avaliar, ameaca e acao

ABCDE na prática — avaliar, ameaça à vida e ação imediata

	Avaliar	Ameaça à vida	Ação imediata
A	Fala? estridor? corpo estranho	Obstrução de via aérea	Aspirar, manobras, IOT/via cirúrgica
B	FR, SpO ₂ , ausculta, expansão	Pneumotórax hipertensivo	O ₂ , ventilar, descomprimir tórax
C	Pulso, PA, perfusão, sangramento	Choque / hemorragia	Comprimir, 2 acessos, volume/sangue
D	AVDI/Glasgow, pupilas, glicemia	Coma, hipoglicemia	Glicose, naloxona, proteger via aérea
E	Expor, pele, temperatura	Hipotermia, lesões ocultas	Aquecer, examinar por inteiro

Fonte: abordagem ABCDE (ATLS/ACLS; Resuscitation Council). 'Treat first what kills first'.

ABCDE NA PRÁTICA

A e B: via aérea e ventilação

- 1 A - fala? estridor? corpo estranho? Aspirar, manobras, IOT se necessário.
- 2 B - FR, SpO₂, ausculta, expansão. Oxigenar e ventilar com bolsa-valvula-mascara.
- 3 Ameaças à vida: obstrução de via aérea e pneumotorax hipertensivo.

Imagem real: ventilação com bolsa-valvula-mascara (Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0).



Condutas de estabilizacao e evidencia

INTERVENÇÃO	INDICAÇÃO	MOMENTO	EVIDÊNCIA
Oxigenio / via aerea	Hipoxemia, rebaixamento, obstrucao	A - B	IA
Volume / hemoderivados	Choque, hemorragia	C	IA
Glicose / naloxona	Hipoglicemia / opioide	D	Ila

Sempre: doses, contraindicacoes e reavaliacao. Em PCR: RCP de alta qualidade e desfibrilacao (ACLS).



Armadilhas x boas praticas

Armadilhas

Pular o A e ir direto ao diagnostico

Nao reavaliar apos cada intervencao

Fixar-se na primeira hipotese (anchoring)

risco

risco

risco

Boas praticas

Reavaliar A->E a cada piora ou conduta

Comunicar com SBAR; usar escores (NEWS2) Equipe com papeis

definidos e lideranca

IA

IB

2a



Pergunta para fixar

Paciente chega dispneico, SpO2 84%, sonolento. Após classificar o risco, qual a

A Solicitar tomografia antes de

B MOVE + ABCDE: garantir via

C Aguardar vaga na enfermaria para iniciar o oxigenio

D Iniciar antibiotico e liberar para observacao

O que levar desta aula

- 01** Triagem prioriza por gravidade, não por ordem de chegada - Manchester da cor e tempo.
- 02** MOVE monta a sala em segundos: monitor, O2, veia e exames, em paralelo.
- 03** ABCDE: trate primeiro o que mata primeiro e reavalie a cada passo.

“Aequanimitas — a serenidade que não falta ao médico diante da urgência.”

WILLIAM OSLER

REFERÊNCIAS

Bibliografia — norma Vancouver

1. Mackway-Jones K, Marsden J, Windle J. Emergency Triage: Manchester Triage Group. 3rd ed. Wiley-Blackwell; 2014.
2. Emergency Nurses Association. Emergency Severity Index Handbook. 5th ed.; 2023.
3. American Heart Association. ACLS Guidelines. Circulation; 2020.
4. Brasil, Ministerio da Saude. Acolhimento com Classificacao de Risco (PNH). Brasilia; 2009.
5. Gilboy N, Tanabe T, Travers D, Rosenau A. Emergency Severity Index (ESI) v4: Implementation Handbook. AHRQ; 2012.
6. American College of Surgeons. ATLS: Advanced Trauma Life Support. 10th ed.; 2018.
7. Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS2). London; 2017.
8. Olgers TJ, et al. The ABCDE approach in critically ill patients: scoping review. 2024.



Obrigado.

Dr. Igor Cruz Moraes

igor.morais@rpt.org.br - WhatsApp (31) 9 9735-4136 - Instagram
@igormorais1